



GUIA GRATUITO · WEBINÁRIO ITH

# CCIH e SCIRAS: **como estruturar o serviço do zero**

Base legal, dimensionamento calculado, plano de 90 dias, documentos obrigatórios e um cronograma de vigilância pronto para usar.



WEBINÁRIO COM

**Esp. Juliana Dias**

Embaixadora do MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente

## BASE LEGAL

# Quem é quem no controle de infecção

Todo hospital no Brasil precisa manter um Programa de Controle de Infecções Hospitalares (Lei nº 9.431/1997). A Portaria MS nº 2.616/1998 organiza esse programa em dois níveis.

| Instância                      | Quem compõe                                                                                                                  | Papel                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CCIH</b> · Comissão         | Membros <b>consultores</b> : representantes de medicina, enfermagem, farmácia, laboratório de microbiologia e administração. | Aprova o programa e as normas, analisa os indicadores, assessora a direção.         |
| <b>SCIH / SCIRAS</b> · Serviço | Membros <b>executores</b> : equipe técnica de nível superior, em geral liderada por enfermeiro.                              | Executa: vigilância, indicadores, auditorias, treinamentos, investigação de surtos. |

**Dimensionamento mínimo (Portaria 2.616/1998):** 2 técnicos de nível superior para cada 200 leitos ou fração, um deles preferencialmente enfermeiro; carga horária diária mínima de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais; acréscimo de horas para leitos de pacientes críticos. Normas estaduais e municipais podem exigir mais.

### CASO ILUSTRATIVO · SITUAÇÃO COMPOSTA A PARTIR DE OCORRÊNCIAS COMUNS, COM DADOS FICTÍCIOS

#### Ana assume o SCIH de um hospital de 120 leitos

Ana, enfermeira assistencial, é convidada a assumir o controle de infecção de um hospital com 120 leitos, sendo 10 de UTI. Encontra uma CCIH que só existe no papel: regimento de 2015, nenhum indicador calculado no último ano e um surto de diarreia na clínica médica investigado "de cabeça".

**O que falhou:** não havia programa anual, vigilância nem rotina de reuniões. A primeira tarefa de Ana não é treinar ninguém: é diagnosticar o hospital e montar a estrutura mínima. O plano de 90 dias da próxima página mostra a ordem.

### CÁLCULO RESOLVIDO

#### Dimensionamento do hospital da Ana

120 leitos = 1 fração de 200 → **2 profissionais de nível superior** no serviço executor

Enfermeiro: **6 h/dia** · segundo profissional: **4 h/dia**

+ acréscimo de carga horária pelos **10 leitos de UTI**, conforme a Portaria e a norma local

Leitura: leve essa conta para a direção por escrito. Dimensionamento abaixo do mínimo é argumento técnico e legal para pedir equipe.

## POR ONDE COMEÇAR

# Plano de 90 dias para estruturar o serviço

1

### Dias 1 a 30 · Diagnóstico

- ☐ Perfil do hospital: leitos, UTI, centro cirúrgico, dispositivos invasivos em uso
- ☐ Levantar o que existe: regimento, POPs, atas, relatórios
- ☐ Conhecer o laboratório de microbiologia e o perfil de resistência
- ☐ Mapear os setores de maior risco

2

### Dias 31 a 60 · Estrutura

- ☐ Atualizar o regimento interno e nomear a CCIH formalmente
- ☐ Escrever o Programa de Controle de Infecção do ano
- ☐ Priorizar 3 POPs: higiene das mãos, precauções, prevenção de IRAS por dispositivo
- ☐ Definir os critérios e a rotina de vigilância (ANVISA)

3

### Dias 61 a 90 · Operação

- ☐ Rodar a busca ativa nos setores prioritários
- ☐ Calcular os primeiros indicadores e notificar ao estado
- ☐ Primeira reunião da CCIH com relatório
- ☐ Treinamentos com base no que o diagnóstico mostrou

## DOCUMENTOS QUE O SERVIÇO PRECISA TER

| Documento                                | Para que serve                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Regimento interno da CCIH                | Composição, atribuições, periodicidade das reuniões                       |
| Programa de Controle de Infecção (anual) | Objetivos, metas, ações e cronograma do ano                               |
| POPs de prevenção                        | Higiene das mãos, precauções, bundles, limpeza, processamento de produtos |
| Relatório mensal de indicadores          | Base para a reunião da CCIH, a direção e a notificação estadual           |
| Atas de reunião                          | Comprovam o funcionamento da comissão em auditorias e fiscalizações       |
| Plano de contingência de surtos          | Quem faz o quê quando surgem casos acima do esperado                      |

### CÁLCULO RESOLVIDO

#### Primeiro indicador da UTI

**Densidade de IPCS** = infecções ÷ cateteres-dia × 1.000 = 3 ÷ 850 × 1.000 = **3,5 por 1.000 cateteres-dia**

**Taxa de utilização de CVC** = cateteres-dia ÷ pacientes-dia = 850 ÷ 1.400 = **0,61** (61% dos pacientes-dia com cateter)

Leitura: compare com o seu próprio histórico e com os dados do seu estado. Utilização alta é sinal para revisar diariamente a indicação de cada cateter.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

## Cronograma mensal de vigilância e rotina do CCIH

Mês/ano: \_\_\_\_\_ Hospital: \_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_

| Atividade                                                          | Sem. 1                   | Sem. 2                   | Sem. 3                   | Sem. 4                   | Responsável |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Busca ativa de IRAS na UTI (2 a 3x por semana)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Busca ativa na clínica médica e na cirúrgica                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Censo diário de dispositivos (CVC, VM, SVD) e pacientes-dia        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Vigilância de sítio cirúrgico (pós-alta em até 30 dias)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Revisão dos resultados da microbiologia e do perfil de resistência | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Auditoria de higiene das mãos (observação direta)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Auditoria de bundles e de precauções/isolamento                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Treinamento ou devolutiva de indicadores para um setor             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Cálculo dos indicadores do mês                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Notificação mensal ao órgão estadual                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Reunião da CCIH com relatório e ata                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

Marque a semana planejada e risque quando concluída. O que não foi feito vai para o mês seguinte com justificativa na ata.



#### PRÓXIMO PASSO

## Quer aprofundar este tema ao vivo?

Este guia resume os pontos centrais. No webinar gratuito com a Esp. Juliana Dias, você vê os exemplos da rotina e tira suas dúvidas no chat.

### Webinário gratuito: CCIH/SCIRAS: estrutura, rotina e carreira

Online e ao vivo. Inscreva-se e receba a data e o link no WhatsApp e no e-mail.

**Quero me inscrever grátis**

[mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-ccih-sciras/](http://mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-ccih-sciras/)

### MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente - 100% EAD

Controle de infecção, gestão de riscos, acreditação e núcleo de segurança do paciente. 440 horas, diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5).

**Conhecer o MBA**

#### Fontes

- Lei nº 9.431/1997.
- Ministério da Saúde. Portaria nº 2.616/1998.
- ANVISA. Critérios Diagnósticos de IRAS e Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS (PNPCIRAS).